

INFORME DE EVALUACIÓN NEUROPSICOLÓGICA

— Variante Profesional —

PACIENTE

José Manuel Herrera Patiño

DOCUMENTO

CC 17012345

FECHA NACIMIENTO

18/06/1945

EDAD

81 años, 0 meses

SEXO

Masculino

ESCOLARIDAD

Bachiller Incompleto

LATERALIDAD

Diestro

FECHA DE EVALUACIÓN

20/06/2026

ORDEN N°

OM-2026-001250

PROTOCOLO APLICADO

Neuronorma Colombia AM + MMSE + GDS-15 + NPIQ

ELABORADO POR

Profesional admin-read

Psicólogo

INFORMACIÓN SOCIODEMOGRÁFICA

Nombre:	José Manuel Herrera Patiño	Lateralidad:	Diestro
Documento:	CC 17012345	Ocupación:	Pensionado
Fecha de nacimiento:	18/06/1945	Ciudad:	Bogotá, D.C.
Edad:	81 años, 0 meses	Acompañante:	Patricia Herrera Moreno
Sexo:	Masculino	Remite:	Neurólogo
Escolaridad:	Bachiller Incompleto	EPS / Asegurador:	Compensar EPS

MOTIVO DE CONSULTA

Deterioro cognitivo progresivo de 5 años. No reconoce familiares cercanos, vagabundeo, incontinencia ocasional. Antecedente de 2 ACV isquémicos. En tratamiento con donepecilo 10 mg.

PRUEBAS APLICADAS

Protocolo: Neuronorma Colombia AM + MMSE + GDS-15 + NPIQ

Prueba	Dominio	Dur.
TMT A	Atención	—
TMT B	Funciones Ejecutivas	—
Span Retención Dígitos Directo	Memoria de Trabajo	—
Span Retención Dígitos Inverso	Memoria de Trabajo	—
Test de Stroop Palabra	Atención	—
Test de Stroop Color	Atención	—
Test de Stroop Palabra/Color	Atención	—
Fluidez Verbal Animales	Lenguaje - Fluidez	—
Fluidez Verbal Fonémica (P)	Lenguaje	—
ViDeno	Lenguaje	—
Grober RL Ensayo 1 (libre)	General	—
Grober RLT - Retención Libre Total (E1)	General	—
Grober RT - Recuerdo Total Claves (E1+)	General	—
Escala de Depresión Geriátrica Yesavag	Socioemocional - Depresión	—
Mini-Mental State Examination (MMSE)	General	—
Escala de Lawton y Brody (IADL)	General	—

ANTECEDENTES

Patológicos / Médicos

Sin antecedentes médicos de relevancia.

Antecedente de trastorno depresivo en tratamiento con sertralina 50 mg/día.

Farmacológicos

Sin medicación actual.

Traumáticos

Niega TEC.

Familiares

Sin antecedentes neuropsiquiátricos de primer grado.

OBSERVACIÓN CLÍNICA

Hallazgos cualitativos durante la administración

Apariencia y conducta

Evaluación neuropsicológica completa. Paciente colaborador. Sin incidentes durante la aplicación.

Memoria

Déficit severo en memoria anterógrada y retrógrada. No recuerda hechos biográficos recientes. Reconoce a cuidadora primaria.

Praxias y gnosias

Sin alteraciones significativas en praxias ni gnosias.

Lenguaje

Lenguaje empobrecido. Parafasias semánticas frecuentes. Comprensión de órdenes simples. Sin discurso espontáneo fluido.

Cociente intelectual (observación)

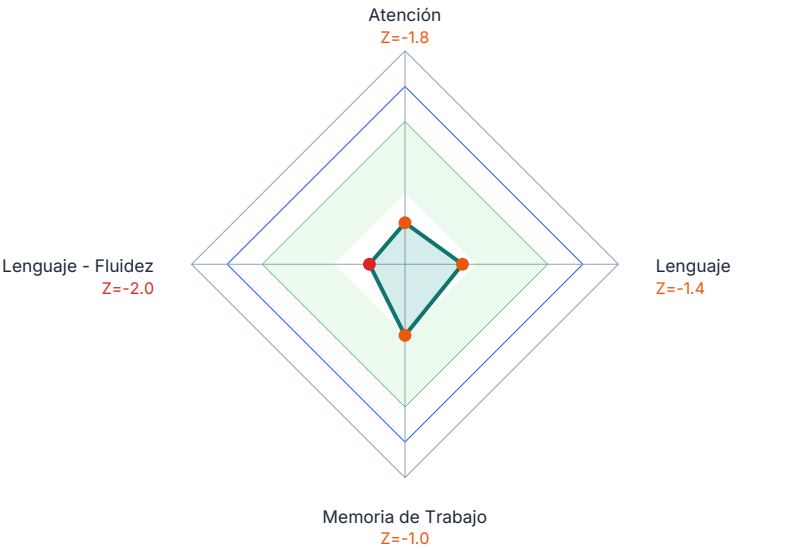
Perfil cognitivo global: F03 - Demencia mixta (Alzheimer + vascular)

RESULTADOS CUANTITATIVOS

Puntajes estandarizados y perfil cognitivo

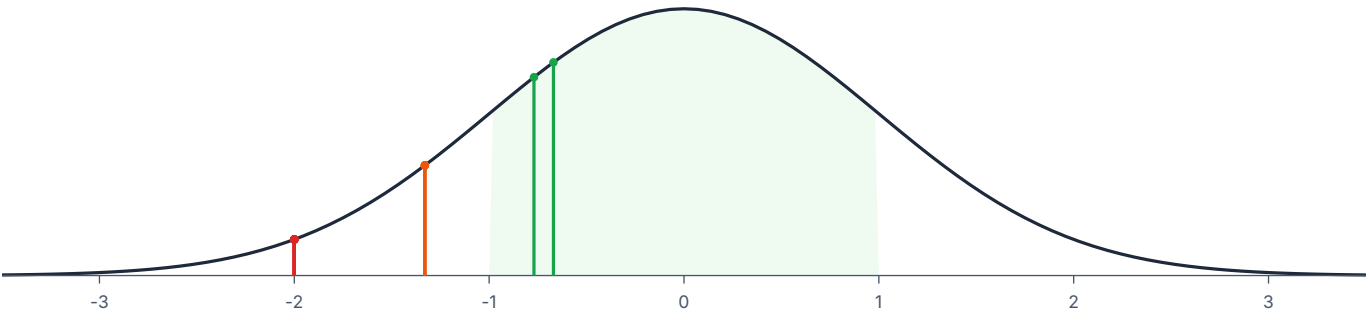


Perfil cognitivo por dominio



Distribución del rendimiento (Z) del paciente sobre la curva normal estándar

n = 12 pruebas con norma disponible



Perfil Z por prueba

PRUEBA	-3	-2	-1	0	1	2	3 Z
TMT A							-1.33
Span Retención Dígitos Directo							-1.33
Span Retención Dígitos Inverso							-0.67
Test de Stroop Palabra							-2.00
Test de Stroop Color							-2.00
Test de Stroop Palabra/Color							-2.00
Fluidez Verbal Animales							-2.00
Fluidez Verbal Fonémica (P)							-2.00
ViDeno							-0.77
Grober RL Ensayo 1 (libre)							-2.00
Grober RLT - Retención Libre Tot							-1.33
Grober RT - Recuerdo Total Clave							-2.00
Escala de Depresión Geriátrica Y							-6.20
Mini-Mental State Examination (M							-5.73
Escala de Lawton y Brody (IADL)							-6.53

Banda verde = rango normal (-1 a +1 σ). Z<-1 sugiere debilidad. Z>+1 sugiere fortaleza relativa.

Tabla detallada de puntajes

Prueba	PD	Escalar/CI	Z	Interpretación
TMT A	250	6	-1.33	Limitrofe
TMT B	—	—	—	Sin dato
Span Retención Dígitos Directo	3	6	-1.33	Limitrofe
Span Retención Dígitos Inverso	1	8	-0.67	Promedio
Test de Stroop Palabra	22	4	-2.00	Bajo
Test de Stroop Color	18	4	-2.00	Bajo
Test de Stroop Palabra/Color	5	4	-2.00	Bajo
Fluidez Verbal Animales	5	4	-2.00	Bajo
Fluidez Verbal Fonémica (P)	2	4	-2.00	Bajo
ViDeno	22	22	-0.77	Limitrofe
Grober RL Ensayo 1 (libre)	2	4	-2.00	Bajo
Grober RLT - Retención Libre Total	2	6	-1.33	Limitrofe
Grober RT - Recuerdo Total Claves	4	4	-2.00	Bajo
Escala de Depresión Geriátrica Yes	7	7	-6.20	Deficit Leve
Mini-Mental State Examination (MMS	14	14	-5.73	Deficit Extremo
Escala de Lawton y Brody (IADL)	2	2	-6.53	Deficit Severo

SÍNTESIS CLÍNICA INTEGRADORA

Lectura cuantitativa de los hallazgos

El perfil neuropsicológico evidencia debilidades en: lenguaje - fluidez (severamente disminuido, $Z=-2.0$); atención (moderadamente disminuido, $Z=-1.8$); general (moderadamente disminuido, $Z=-1.8$); lenguaje (moderadamente disminuido, $Z=-1.4$); memoria de trabajo (moderadamente disminuido, $Z=-1.0$).

Entre las pruebas con mayor desviación se encuentran Test de Stroop Palabra ($Z=-2.00$, bajo); Test de Stroop Color ($Z=-2.00$, bajo); Test de Stroop Palabra/Color ($Z=-2.00$, bajo). Estos hallazgos orientan la formulación diagnóstica y la priorización de objetivos de intervención.

Áreas con desempeño disminuido

- Fluidez Verbal Animales — bajo ($Z=-2.00$)
- Fluidez Verbal Fonémica (P) — bajo ($Z=-2.00$)
- Grober RL Ensayo 1 (libre) — bajo ($Z=-2.00$)
- Grober RT - Recuerdo Total Claves (E1+E2+E3) — bajo ($Z=-2.00$)
- Test de Stroop Color — bajo ($Z=-2.00$)
- Test de Stroop Palabra — bajo ($Z=-2.00$)

RESUMEN PARA LA FAMILIA

Lenguaje sencillo para padres, cuidadores y paciente

Saludo

Este es un resumen de la evaluación que se realizó José. Está escrito en un lenguaje sencillo para que sea fácil de entender. Tu psicólogo o psicóloga te explicará los detalles y resolverá cualquier duda que tengas.

¿Qué hicimos en la evaluación?

Realizamos varias pruebas que miden cómo funciona tu cerebro en distintas situaciones: memoria, atención, lenguaje, razonamiento y la velocidad con la que procesas información. Las pruebas son como "pequeños retos" que se resuelven con papel, lápiz y a veces con cubos o figuras. No hay respuestas buenas ni malas: lo que nos interesa es conocer cómo trabaja tu mente.

¿Qué encontramos?

Las áreas donde te fue bien incluyen: En ViRDInv, tu rendimiento fue dentro del rango esperado. Las áreas donde se recomienda trabajar incluyen: En ViStP, tu rendimiento fue por debajo del promedio. Esto se puede trabajar con práctica y apoyo. En ViStC, tu rendimiento fue por debajo del promedio. Esto se puede trabajar con práctica y apoyo. En ViStPC, tu rendimiento fue por debajo del promedio. Esto se puede trabajar con práctica y apoyo.

¿Qué se recomienda trabajar?

- En ViRDInv, tu rendimiento fue dentro del rango esperado.
- En ViStP, tu rendimiento fue por debajo del promedio. Esto se puede trabajar con práctica y apoyo.
- En ViStC, tu rendimiento fue por debajo del promedio. Esto se puede trabajar con práctica y apoyo.
- En ViStPC, tu rendimiento fue por debajo del promedio. Esto se puede trabajar con práctica y apoyo.
- En ViAni, tu rendimiento fue por debajo del promedio. Esto se puede trabajar con práctica y apoyo.
- En ViP, tu rendimiento fue por debajo del promedio. Esto se puede trabajar con práctica y apoyo.

¿Qué recomendamos?

Sobre la terapia: continúa con tus sesiones según lo acordado. Si tienes dudas, coméntalas con tu terapeuta.

Preguntas frecuentes

- ¿Mis resultados son permanentes?
No necesariamente. El cerebro puede cambiar con el tiempo, especialmente con práctica y los apoyos adecuados. Los resultados que obtuviste son una foto del momento actual.
- ¿Por qué algunos resultados son mejores que otros?
Es completamente normal. Todas las personas tienen áreas donde son más fuertes y áreas donde pueden mejorar. Esto no significa que haya algo mal en ti.